

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	認知障礙症（失智症） Major Neurocognitive Disorder (Dementia)				
編號	A31000-Q03-W-A10	制定者	PSY 李家靜	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.6 版/13 頁	審查者	曾翊健	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員對認知障礙症（失智症）的定義、症狀區辨、篩檢及評估、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

精神疾病診斷統計手冊第五版(DSM-5)將失智症更名為認知障礙症。認知障礙症（失智症）是一種漸進性不可逆的腦部退化疾病，其診斷標準包含一至多項知能功能缺損，主要之缺損為注意力、執行能力、學習和記憶、語言、感覺與動作整合及社會人際認知，六項中符合一項，並在學習、社會、職業功能上有缺損，同時需排除譫妄。認知障礙症（失智症）病人之視覺空間、空間定向感、判斷力、計算力、抽象思考力、注意力、語言等認知功能皆可能出現障礙，其行為與精神症狀亦可能出現明顯的異常，包括：情緒容易變化、躁動行為、遊走及攻擊行為等。

（二）分類

- 1.神經退化性認知障礙（阿茲海默症、額顳葉、路易氏體、帕金森氏症、亨丁頓氏症）。
- 2.血管性認知障礙（腦中風或慢性腦血管病變）。
- 3.續發性認知障礙（感染、代謝障礙、腦部疾病）。

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	2/13

(三) 症狀

1. 身體層面：意識正常，但個別病情差異，病徵階段也因人而異；易有睡眠障礙、出現日落症候群，說話內容貧乏、不連貫、重複或多話。可能出現異於平常的行為，如隨地吐痰、拿店中物品卻未給錢、衣衫不整等。因認知障礙導致的飲食行為問題：如無法順利將食物放進口中咀嚼、注意力不集中、吞嚥困難、抗拒進食等。
2. 情緒層面：行為與情緒出現改變，顯得急躁、衝動、憂鬱或焦慮，患者的情緒欠穩，而改變不一定有可理解的原因。個性方面的變化，如易猜疑、口不擇言、過度外向、失去自我克制；晚期顯淡漠，活動力及開創力喪失，如：患者變得更被動，需要催促誘導才會參與事務。原本的興趣嗜好也不想去做。
3. 智能層面：由於記憶力的退化或是生活獨立性的改變，患者常見的心理反應有失落、憤怒、不確定感、和挫折，例如常有患者說到以前記憶很好，可以過目不忘或是記數百組電話號碼，但又自我貶抑，例如：說自己「年紀大了沒用了」，或是說「現在連這個都做不好」，因此在行為上可能會社交退縮、話量少，甚至有焦慮或憂鬱等症狀。
4. 思考層面：患者在於意識清醒，且身體功能良好的狀態下，無法思考較複雜的問題、短期記憶及判斷力喪失、自身行為能力出現錯亂、容易情緒失控發生身體攻擊行為、產生妄想、幻覺、語言障礙、無法集中注意力、個性明顯改變、面對較多樣化的事物無法適時做出反應等，發病後心智功能退化將無法復原。
5. 社會與靈性層面：出現重複性、漫無目的的徘徊遊走等不恰當的行為。

(四) 臨床常見評估量表

1. 簡易智能狀態檢查(Mini-Mental State Examination, MMSE)：

是最常使用的認知障礙症評估工具之一，評估項目包括定向感、注意力與計算能力、記憶力、語言、建構力等功能，分數從 0（最差）至 30（最好）；若受檢者的教育程度為國中以上，其分數低於 24 分可能表示受檢者有認知功

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	3/13

能異常，小學程度者則為 21 分，未受教育程度者為 16 分。

2. 臨床失智評估量表(Clinical Dementia Rating, CDR)：

針對阿茲海默症患者日常生活與認知功能做整體性評估的量表，是評估失智症嚴重程度的主要工具之一。臨床失智評估量表包含 6 個功能項目：記憶、定向力、判斷與解決問題、社區事務、家居與嗜好、個人照料。對上述的 6 個功能項目，分為 0-3 的 5 個不同功能程度：0 代表健康，0.5 代表疑似或輕微障礙，1 代表輕度障礙，2 代表中度障礙，3 代表重度障礙。

(五) 常見治療

目前為止尚沒有任何藥物或治療方法可以阻止或逆轉認知障礙症（失智症）的病程。首先找出可治療的病因加以治療，如腦膜炎、水腦、甲狀腺功能低下等，症狀即可獲得明顯改善。

1. 血管性失智症以控制血壓與代謝症候群的相關風險，預防再次中風，使用抗凝血劑 aspirin。
2. 阿茲海默症的藥物治療：

治療認知障礙症的藥物主要減緩患者心智功能退化的程度，並且改善患者精神行為症狀。目前全民健保的給付範圍的處方藥物包括乙醯膽鹼酶抑制劑(acetyl-cholinesterase inhibitor)及 N-甲基-D-天門冬胺酸受體拮抗劑(N-methyl D-aspartate antagonists; NMDA antagonists)，其他藥物則包括抗精神病藥物、抗憂鬱藥等，可用來改善患者的精神行為症狀。

(1) 乙醯膽鹼酶抑制劑(acetyl-cholinesterase inhibitor)，機轉為抑制乙醯膽鹼被分解以增加腦中乙醯膽鹼濃度。主要是針對輕中度認知障礙（失智）病人，常見藥物有愛憶欣(donepezil; Aricept[®])、憶思能(rivastigmine; Exelon[®])、利憶靈(galantamine; Reminyl[®])，以上適用於輕度至中度阿茲海默症患者，常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、食慾減退、頭痛等。

(2) N-甲基-D-天門冬胺酸受體拮抗劑(N-methyl D-aspartate antagonists; NMDA antagonists)，主要作用為抑制腦部神經元的毒素作用。對中、重

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	4/13

度阿茲海默症較為有效，有憶必佳或威智(memantine; Ebixa[®]或 Witgen[®])，副作用包括眩暈、躁動、尿失禁、失眠等。

3. 非藥物治療：

藉由環境的調整、活動的安排，鼓勵參與團體互動，包含以下多種方法：

- (1) 認知導向，如：懷舊治療(remembrance therapy)、現實導向療法(reality orientation therapy, ROT)、認知刺激治療等。
- (2) 感覺刺激，如：芳香療法、光照治療、按摩／觸摸、音樂治療、多感官療法等。
- (3) 其他社會心理性介入，如：運動團體、寵物治療、藝術治療、園藝治療、遊戲治療等，能改善認知障礙患者行為情緒症狀。

(六) 護理問題

1. 易跌倒／認知障礙
2. 自我照顧尋求協助：沐浴、衛生／認知障礙。
3. 睡眠障礙／認知障礙
4. 知覺感受變異／正性症狀
5. 思考過程異常／精神症狀干擾
6. 吞嚥功能障礙/認知障礙
7. 易對別人傷害或暴力／認知障礙

(七) 護理措施

1. 易跌倒／認知障礙
 - (1) 病人臥床時使用床欄並注意床欄穩固，降低病床高度。
 - (2) 清除障礙物，保持地面乾燥，穿著合適的止滑拖鞋及衣褲。
 - (3) 護理人員定時查看病人情形。
 - (4) 提供安全的環境：浴廁裝置安全扶手及防滑設備，避免地板濕滑，保持夜間適當的光線。
 - (5) 教導病人及家屬或看護使用緊急鈴並置於適當位置。

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	5/13

(6)必要時依醫囑給予適當的約束。

(7)提供紅色手圈配戴。

2. 自我照顧尋求協助：沐浴、衛生／認知障礙

(1)排泄

- A. 定時上廁所、預測需要、辨認尿意訊號（如拉扯褲子）。
- B. 用鮮明圖片標示廁所位置；馬桶周邊顏色鮮明，以利對準目標。
- C. 選擇易穿脫的褲子。
- D. 攝取足夠水分及纖維質、每天固定活動身體以利排便。
- E. 弄髒衣服環境時，不責罵、羞辱病人，因為長輩不是故意的，責罵也無法避免再弄髒的機會。
- F. 記錄排便情形，長時間未解尿或解便時，注意有無便秘或尿路感染問題。
- G. 注意晚間飲水量，準備馬桶椅於床旁或廁所開燈，陪伴長輩半夜解尿。

(2)穿衣

- A. 衣服簡單化：鬆緊帶、粘貼式、方便穿脫、少鈕扣。
- B. 予簡單的選擇：二選一。
- C. 按穿衣順序排好，讓長輩自己穿。
- D. 注意天氣改變，協助增減衣物。
- E. 長輩喜歡穿的衣服，多準備幾套。

(3)沐浴

- A. 了解不洗澡的可能原因。
- B. 選擇病人心情好的時間或評估最適合洗澡的時間。
- C. 順著過去的洗澡習慣，可以由長輩自己在日曆上作記號，洗澡時間及方式固定：病人較易遵從，較有安全感。依長輩狀況彈性調整方式：可坐著洗、可站著洗、可在浴室洗、可在廁所洗、可在房間擦澡、可分段洗（上廁所時洗下半身、心情好時洗上半身）。

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	6/13

- D. 預先營造安全舒適的洗澡環境：注意浴室內溫暖、地面及浴盆底有止滑設施、牆上有扶手、準備好洗澡水和衣物、明亮光線（減少錯覺產生），給長輩和充裕的時間。
- E. 病人能做的盡量讓病人做，分解動作，一口令一動作，做不好沒關係，幫他完成即可；多鼓勵，完成時立即鼓勵：讚美長輩（年輕、皮膚美麗、香噴噴、帥、「煙斗」）。少責備、少催促。
- F. 給長輩簡單的選擇機會，讓他覺得可控制，如先洗臉或先洗背、先穿褲子或上衣。
- G. 拒洗時，暫時順他，轉移注意出去走走，待會兒再試。
- H. 重視隱私與舒適，動作溫和，可予大浴巾包身體，或在背後協助以減少尷尬。
- I. 使用中性肥皂以免皮膚乾燥易導致搔癢或龜裂。
- J. 指導及協助病人在能力範圍內，盡可能讓病人處理自己的日常生活，依序執行各項活動，並適時予以鼓勵及支持。

3. 睡眠障礙／認知障礙

- (1) 做睡眠活動日記，評估導致睡眠問題的原因。
- (2) 逐漸增加白天活動量，形成規律作息。
- (3) 維持適當的休息與睡眠，有計畫及規律性安排白天治療性活動。
- (4) 建立睡覺的儀式，如每天睡前固定刷牙、上廁所、聽喜歡的輕柔音樂、聽一個古老的故事、五分鐘按摩等。
- (5) 日夜顛倒嚴重者，必要時請醫師開立幫助睡眠的藥物，依醫囑給病人服用。
- (6) 注意飲水量，減少半夜尿床或起身上廁所的機會。
- (7) 半夜起床時，提供一個安全的活動空間，必要時請家屬陪伴以免發生意外。

4. 知覺感受變異／正性症狀

- (1) 與病人建立信任之治療性關係，觀察病人的行為與症狀表現。
- (2) 鼓勵病人表達對幻覺的感受，採接受性的態度同理其內在的焦慮不安及害

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	7/13

怕，並給予正向的回饋。

(3)傾聽病人在幻覺出現時的不適感，不與其爭辯。

(4)預防因受幻覺影響而引起的自我傷害。

(5)安排活動來轉移對幻覺的注意（如聽音樂、看電視等）或與人談天來轉移注意力。

(6)鼓勵病人與其信賴的人一同驗證其幻覺的真實性。

5. 思考過程異常／精神症狀干擾

(1)讓病人了解雖然護理人員並不同意其妄想但可接受他有妄想存在，不要與病人爭論或否認其信念，或企圖說明讓他相信其妄想不是真的。

(2)安排活動如看電視、唱歌、聽音樂等以轉移注意力。

(3)鼓勵其說出內在的焦慮害怕及不安全感等，並予傾聽同理。

(4)會談時強調並集中注意於現實的情境，談論真實的人與事，出現合乎現實想法時給予正向加強。

(5)避免隨意碰觸病人，與其討論妄想對其日常生活所帶來的困擾。

(6)傳遞訊息時言語清晰明確，避免開玩笑，若拒絕治療時，先暫時離開，稍候再試。

(7)協助病人區分妄想與現實。提供現實導向治療：懸掛大型日曆、時鐘，病室內可設置大型指示牌，熟悉的個人物品（如照片、心愛的擺飾等）；盡量不更動病人的房間及擺設，均可加強病人對人實地之定向感。利用色彩或圖案，以幫助分辨事物。

(8)醫護人員需告知照顧者認知障礙症（失智症）藥物相關資訊，了解症狀控制之重要性，並提供主要照顧者個別化輔導，有助於了解認知障礙症（失智症）症狀及日常生活之照護相關知識。

(9)教導家屬相關因應策略運用，以維持良好關係減少衝突產生，也學習尋求可利用的社會支持或資源，並提供相關衛教及照護技巧訓練。

6. 吞嚥功能障礙／認知障礙（失智）

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	8/13

- (1) 監測意識狀態、咳嗽反射、嘔吐反射及吞嚥功能等。
- (2) 觀察吞嚥困難引起之合併症，如噎咳、吸入性危險。
- (3) 維持病人進食時的安全姿勢，採坐姿 90 度或床頭搖高 45-60 度，於餐後維持坐姿 30-45 分鐘，避免食物逆流或打嗝噎咳。
- (4) 盡量三餐菜色有變化，以維持病人食慾。
- (5) 緩慢進食，在病人吞嚥時避免分散其注意力。
- (6) 每週量體重，監測營養狀況。
- (7) 教導家屬及病人選擇適合吞嚥的食物與性質，如半流質或軟質，避免液體食物；避免食用體積較大、具有黏性的食品，如湯圓、麻糬、饅頭、果凍等。
- (8) 確定病人已順利吞嚥且口腔內沒有食物後，再給下一口食物，若發生噎咳，應立即停止進食。
- (9) 保持口腔衛生，進餐後應給予口腔清潔，並確定無殘留食物在口中。
- (10) 教導病人口腔運動及安全吞嚥技巧，增進吞嚥機能。
- (11) 協同健康照護小組的其他成員（例如：職能治療師、語言治療師及營養師等）提供病人持續性復健計劃。

7. 易對別人傷害或暴力／精神疾病症狀

- (1) 評值目前的暴力危險因子，如：年輕、男性、暴力史、壓力、物質濫用史等。
- (2) 親視服藥並衛教規則服用藥物的重要性，視需要時給予依臨時醫囑藥物幫助控制行為。
- (3) 運用會談技巧了解病人的需要及感受。
- (4) 引導思考其他的選擇或替代方案，以減少暴力之產生，如：深呼吸可放鬆並減輕焦慮；運動、散步或提供保護室給予大喊、搥打海綿牆，以發洩情緒。
- (5) 監測瀕臨暴力發作的症狀（如：握拳、說話音量大、咬牙切齒等）勿單

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	9/13

獨接觸正憤怒中的病人、注意安全距離（2-3呎）、勿觸摸病人，呼叫尋求其他工作人員支援。

- (6) 出現暴力行為時，聯絡醫師評估約束及保護隔離的必要性，約束病人的身體以控制暴力行為，防止進一步的傷害，提供一個安靜、清爽的環境空間，以減少環境刺激；並以冷靜、平穩的語氣向病人解釋我們做了什麼及為何要如此做。
- (7) 每15分鐘密切觀察及探視，監測藥物的副作用及病人的精神及情緒狀態，約束過程要提供充足的水分、營養及維持個人衛生。
- (8) 引導病人表達對此事件之感受，對其不合現實的認知及被害感受需立即澄清。
- (9) 提供社會心理治療措施，改善認知障礙症行為情緒症狀。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）李燕玲、陳怡亨(2024)．失智症攻擊行為的臨床評估與處置．長期照護雜誌，27(1)，77-91。
- （二）許寶鶯(2020)．認知類障礙症的護理．於蕭淑貞（總校閱），精神科護理學（五版，376-402 頁）．新北市：新文京開發。
- （三）陳可心、柯妙馨、劉美吟、王靜枝(2022)．失智症者之迷路-範域文獻回顧．護

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	10/13

理雜誌，69(1)，100-113。

(四) 鄒建萍、湯麗玉(2021)·認知類障礙症之護理·於蕭淑貞(總校閱)，精神科護理概論-基本概念及臨床應用(十版，524-558頁)·台北市：華杏。

(五) American Psychological Association. (2014)·DSM-5 精神疾病診斷準則手冊(臺灣精神醫學會譯)·台北市：合記圖書出版社。(原著出版於2013)

(六) 陳冠誠、郭明哲、鄭穎、王亭貴(2020)·失智症吞嚥照顧評估及治療·長期照護雜誌，24(1)，1-14。

七、附件

(略)

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	11/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改參考文獻	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1. 更新及修訂定義、範圍及說明與護理措施內容及參考文獻。 2. 醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	說明內容部份修訂及參考文獻內容增修	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	1. 說明內容部份修辭及修正錯別字和標點符號。 2. 參考資料文獻部份內容更新。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.02.03	3.3	1. 主題名稱改為：認知障礙症（失智症）。 2. 第三項第（一）、（四）、（五）、（六）目之說明內容刪除：失智症；改為認知障礙症（失智症）。 3. 新增第六項第（七）目之參考文獻。	104 年 02 月 03 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	3.4	第六項參考文獻資料刪修及修訂 APA 格式	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.5	4. 參考文獻新增於內文。 5. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.02.06	3.6	1. 第三項說明內容部份增刪、修辭及修正錯別字。 2. 新增第六項參考資料。	106 年 02 月 06 日護理部照護標準委員會通過

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	12/13

修正日期	版本	修正說明	備註
106.08.31	3.7	1. 第三項說明第(二、三、四、五)內容部份增刪。 2. 第六項參考資料文獻部分更新。	106年08月31日 護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.8	第二項新增(含中興分院)。	107年09月12日護理長會議通過
108.09.11	3.9	1. 第三項第一、二、四目之說明內容修訂。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第六項參考資料文獻部分更新。	108年09月11日護理長會議通過;108年09月23日督導會議通過公布。
109.08.18	4.0	1. 第三項內容部份增刪及修正辭彙。 2. 第六項參考資料文獻部分更新。	109年08月06日照護標準組會議通過; 109年08月12日護理長會議通過;109年08月18日督導會議通過公布。
110.09.07	4.1	1. 第三項第一、二、四、六目之說明內容修訂。 2. 第六項參考資料刪除。	110年08月05日照護標準組會議通過; 110年08月11日護理長會議通過;110年09月07日督導會議通過公布。
111.09.06	4.2	1. 第三項第二目之1、4項之說明內容修訂。 2. 第三項第五、六目護理護理問題修正。 3. 第六項參考資料文獻部份增刪及更新。 4. 內文參考文獻統一刪除。	111年08月04日照護標準組會議通過; 111年08月10日護理長會議通過;111年09月06日督導會議通過公布。
111.11.08	4.3	因應失智症疾病認證，需增加以下內容： 1.第三項第二目之1、4項之內容修訂。 2.第三項第五、六目護理問題及護理措施部分新增。 3.第六項參考資料文獻部分新增。	111年10月06日照護標準組會議通過; 111年10月12日護理長會議通過;111年11月08日督導會議通過公布。

主題名稱	認知障礙症(失智症)	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A10	版本	第 4.6 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註
112.09.05	4.4	1. 第三項第五、六目護理問題修正。 2. 第六項參考資料文獻部份刪除。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	4.5	1. 第三項第一目說明內容文字修訂。 2. 新增第三項第二目分類。 3. 第三項第七目之 1.(3)說明內容文字修訂。 4. 第六項參考資料文獻部份增刪。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	4.6	1.第六項參考資料文獻部份增刪。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。